

Grile varianta B

1.* Orbitele:

- A. Reprezintă spațiile care adăpostesc doar anexele globului ocular.
- B. Reprezintă spațiile care adăpostesc globul ocular și anexele acestuia.
- C. Reprezintă spațiile care adăpostesc doar globul ocular.
- E. Topografic, sunt așezate în etajul inferior al neurocraniului.

2.* Miopia:

- A. Reprezintă o tulburare de refracție în care razele paralele, venite de la infinit, se focalizează în fața retinei.
- B. Majoritatea miopiilor sunt datorită axului prea mic al globului ocular.
- C. Majoritatea miopiilor sunt datorită axului prea mare al globului ocular.
- D. Reprezintă o tulburare de refracție determinată de existența mai multor axe cu puteri diferite la nivelul corneei.
- E. Se corectează cu lentile cilindrice.

3*. Avantajele corecției cu lentile de contact:

- A. Nu sunt estetice.
- B. Confort sporit la pacienții cu activități fizice (de exemplu sport), la care ochelarii pot fi deranjați.
- C. Nu permit corecția anizotropiei.
- D. Acuitate vizuală mai scăzută pentru miopi.
- E. Îngustează câmpul vizual periferic.

4* Care afirmație este falsă referitoare la conjunctivite?

- A. Conjunctivita herpetică este o conjunctivita virală
- B. Conjunctivitele cu adenovirusuri sunt extrem de contagioase
- C. Conjunctivita gonococică este o conjunctivita bacteriană
- D. Conjunctivitele virale, spre deosebire de cele bacteriene, sunt de regula foliculare
- E. Conjunctivitele bacteriene, spre deosebire de cele virale, sunt de regula foliculare

5* Semnele și simptomele conjunctivitei cu adenovirusuri sunt următoarele cu excepția :

- A. Conjunctiva este congestionată și edematiată
- B. Există o hiperproducție de secreție lacrimo-conjunctivală de tip seros
- C. Dacă este afectată și corneea, keratita se manifestă fie sub forma de “punctata superficială”, fie sub forma de infiltrate multiple
- D. Pleoapele sunt ușor edematiată
- E. Semnele clinice se succed în patru stadii evolutive

6 *Ce reprezintă dezlipirea de retină?

- A. separarea epiteliului pigmentar retinian de membrana Bruch
- B. separarea retinei neurosenzoriale (cele 9 straturi interne) de epiteliul pigmentar retinian
- C. separarea retinei neurosenzoriale (cele 10 straturi interne) de epiteliul pigmentar retinian
- E. separarea retinei neurosenzoriale de membrana Bruch

F. separarea retinei la nivelul membranei limitante externe

7.* Anomalia discală “morning glory”:

7A

- A. este o excavație congenitală a globului ocular posterior care implică discul optic
- B. este o lipsă de substanță la nivelul discului optic
- C. este ca o depresiune asemănătoare unui crater, rotundă sau ovală, gri, albă sau galbenă, la nivelul discului optic.
- D. este un disc optic anormal de mare și căruia îi lipsește excavația inferioară a colobomului discului optic
- E. aspectul oftalmoscopic este acela al unui cap de nerv optic mic, gri sau pal

8.*Care este valoarea normala a PIO?

8 A

- A. 15,5 mmHg cu o deviație standard de 2,6 mmHg.
- B. între 27-28 mmHg
- C. 21 mmHg
- D. sub 11 mmHg
- E. peste 21 mmHg

9.* următoarea afirmație este corectă:

9 B

- A. Vitrosul este un gel opac
- B. Vitrosul conține 99% apă
- C. Vitrosul este bogat vascularizat
- D. Vitrosul este bogat innervat
- E. Vitrosul umple spațiul dintre coroidă și retina

10.* următoarea afirmație referitoare la cataractă legată de vârstă este falsă:

10 B

- A. În funcție de dispoziția opacităților în cristalin poate fi: nucleară, subcapsulară posterioară, zonulară sau mixtă
- B. Evoluția este rapidă, în 24-48 de ore
- C. Evoluția este lentă, se poate întinde pe ani de zile
- D. Principalul simptom este scăderea acuității vizuale
- E. Tratamentul este strict chirurgical

11. Retina:

11ABE

- A. Reprezintă tunică internă a globului ocular.
- B. Reprezintă tunică care are funcție fotoreceptoare.
- C. Macula lutea reprezintă zona periferică a retinei.
- D. Ora serata = zonă de tranziție dintre retină și corneă.
- E. Vascularizația este asigurată de artera centrală a retinei și coriocapilară.

12. Ectropionul:

12ABCD

- A. Reprezintă o eversare a marginii libere palpebrale.
- B. Este o afecțiune unilaterală sau bilaterală.
- C. Cuprinde mai multe forme din punct de vedere etiologic: senilă, paralică, cicatricială, congenitală, mecanică.
- D. Tratamentul este întotdeauna chirurgical.

E. Forma paralică apare în urma parezei periferice de nerv oculomotor.

13. Următoarele afirmații sunt adevărate:

- A. Cornul cutanat palpebral reprezintă o tumoră benignă palpebrală.
- B. Chalazionul reprezintă o afecțiune inflamatorie chistică a pleoapei.
- C. Hemangiomul capilar (cavernos) apare, de regulă, la scurt timp după naștere.
- D. Melanomul malign este frecvent întâlnit la pleoape.
- E. Carcinomul bazocelular nodular se prezintă sub forma unui nodul de consistență elastică.

14. Prezbiopia:

- A. Reprezintă o tulburare patologică a acomodatiei.
- B. Se manifestă prin scăderea amplitudinii de acomodatie.
- C. Mecanismul prezbiopiei este dat de scăderea lentă a elasticității cristalinului.
- D. Corecția: lentile convergente.
- E. Se manifestă prin dificultate în formarea și menținerea unei imagini clare a obiectelor situate mai aproape de punctul remotum.

15. Aparatul lacrimal:

- A. Este format din glandele Meibomius și căile lacrimale.
- B. Secreția glandei lacrimale principale se varsă la nivelul fornixului superior al conjunctivei.
- C. Este format din glandele lacrimale și căile lacrimale.
- D. Căile lacrimale sunt reprezentate de canaliculele lacrimale, sacul lacrimal, canalul nazo-lacrimal.
- E. Glanda lacrimală principală se află situată în fosa glandei lacrimale.

16. Herpes zoster oftalmic:

- A. Reprezintă manifestarea clinică, cutanată, a infecției cu virusul varicelo-zosterian la nivelul pleoapei superioare.
- B. Afecțiunea se localizează doar la una din pleoapele superioare.
- C. Se întâlnește în special la persoanele în vârstă, cu diverse grade de imunodeficiență.
- D. Tratament: antiinflamatoare nesteroidiene.
- E. Simptomul dominant este conjunctivita bacteriană.

17. Hiperlăcrimarea

- A. poate fi primară sau reflex
- B. poate fi doar reflexa
- C. Forma primară apare datorită afectării directe a glandei lacrimale, în caz de tumori, chisturi, anumite medicamente
- D. Forma reflexă apare ca rezultat al iritației corneei (eroziuni corneene, ulcere corneene)
- E. O formă particulară de hiperlăcrimare reflexa este cea a sugarului în timpul suptului.

18. Dacriocistita dobândită- forma acută :

- A. este inflamația acută a sacului lacrimal
- B. cel mai frecvent apare în urma exacerbării unei dacriocistite cronice
- C. tratament: antibioterapie generală și locală, antiinflamatoare steroidiene; în caz de abces, tratament chirurgical.

D. Simptomatologie și semne oculare: durere pulsatilă în dreptul cantusului medial; masă fluctuantă, dureroasă, bine delimitată

E. Simptomatologie și semne oculare: lăcrimare cronică accentuată la frig, vant, lumină puternică, după luni, ani de zile sacul lacrimal se dilată și tumefiază

19. Conjunctivitele alergice:

19 ABCE

A. Conjunctivita vernala (primavaratica) afecteaza predominant copii și adultii tineri și în special sexul masculine

B. la baza sta o reactie de hipersensibilitate de tip I și IV

C. pacientul resimte fotofobie, senzatie de corp strain pe suprafata oculara și senzatie de arsura, dar simptomul primordial este reprezentat de prurit

D. Episoadele de acutizare se trateaza în special prin administrare topica de corticosteroizi

E. Se administreaza corticosteroizi atat sistemic cat și topic

20. Rolurile sclerei:

20 ABC

A. menține forma globului ocular

B. rol protector și servește de aponevroză pentru inserțiile musculaturii extrinseci și intrinseci a globului ocular

C. contribuie la reglarea tensiunii intraoculare

D. secreta filmul lacrimal

E. secreta stratul apos al filmului lacrimal

21. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

21 ACD

A. în cazul subiecților cu grosime corneeană centrală mai redusă (sub 555 μm) valorile PIO determinată

aplanotonometric pot fi subevaluate

B. în cazul subiecților cu grosime corneeană centrală mai redusă (sub 555 μm) valorile PIO determinată

aplanotonometric pot fi supraevaluate

C. PIO reprezintă cel mai important factor de risc în producerea atrofiei optice glaucomatoase cât și a apoptozei fibrelor capsulei nervului optic

D. La subiecții neglaucomatoși există o variație nictemerală a curbei presiunii intraoculare (PIO)/24 de ore cuprinsă între 2-6 mmHg.

E. Umorul apos este format (secretat) la nivelul mușchiului ciliar

22. Ocluzia de arteră centrală a retinei – semne clinice:

22 ACDE

A. edem retinian difuz, retina are aspect palid

B. hemoragii în flacăra

C. reflex portocaliu dat de vascularizația coroidiană intactă de sub foveolă “cireasă maculară”

D. îngustarea și subțierea arterelor retiniene

E. întreruperea circulației sanguine în arterele obstruate

- 23 BCE 23. Retinopatia diabetică – clasificare:
- A. neoproliferativă – ușoară: hemoragii retiniene severe în 1-3 cadrane retiniene sau AMIR ușoare;
 - B. neoproliferativă – moderată : dilatații venoase sub formă de mărgelile doar într-un cadran, exudate ischemice
 - C. neoproliferativă – severă : hemoragii severe în toate cele 4 cadrane dilatații venoase sub formă de mărgelile în 2 sau mai multe cadrane
 - D. proliferativă - ușoară – moderată : neovase asociate cu hemoragie vitreană sau preretiniană
 - E. proliferativă - risc înalt : neovase $>1/2$ din suprafața discului cu hemoragie vitreană sau preretiniană

- 24 ABD 24. Nevrita optică retrobulbară caracteristici:
- A. Discromatopsie
 - B. Defect pupilar aferent
 - C. Pierderea graduală a vederii
 - D. Durere, în special la mișcarea globului ocular
 - E. Miodezopsii

- 25 ADE 25. Leziunile chiasmatică se evidențiază la câmpul vizual sub formă de:
- A. hemianopsie bitemporală
 - B. cecitate bilaterală
 - C. hemianopsie omonimă
 - D. Scotoame hemianoptice arcuate
 - E. cvadranopsie superioară bitemporală

- 26 ACE 26. OVCR nonischemică (perfuzată) caracteristici:
- A. acuitatea vizuală este relativ conservată sau moderat afectată
 - B. defectul pupilar aferent relativ (DPA) este prezent
 - C. vene dilatate și tortuoase, hemoragii în forma de flacără, hemoragii punctiforme dispuse în toate cele patru cadrane retiniene, edem macular
 - D. Tomografia în coerență optică (OCT): evaluează edemul macular, care este o complicație rară
 - E. Angiofluorografia (AFG): se observă o întârziere a timpului de tranzit arterio-venos, perfuzie capilară păstrată.

- 27 ABCD 27. examinarea corneei se poate realiza cu ajutorul:
- A. Biomicroscopiei
 - B. Topografiei corneene
 - C. Microscopiei speculare
 - D. Pahimetriei
 - E. Oftalmodinamometriei

- 28 ABC 28. In cazul unei plagi corneene penetrante apare:
- A. Hipotonia oculara
 - B. Camera anterioara de profunzime redusa
 - C. Scurgerea de umor apos din camera anterioara
 - D. Heterocromia iriana

E. Hipertonia oculara

29. complicatiile postoperatorii tardive ale operatiei de cataracta sunt:

- 29 ABCD
- A. Keratopatia buloasa
 - B. Glaucom secundar cronic
 - C. Astigmatismul rezidual
 - D. Opacifierea capsulei posterioare
 - E. Prolapsul in cavitatea vitreana a nucleului cristalinian

30. tumorile corneei

- 30 CD
- A. Sunt foarte des intalnite
 - B. Fibromul este o tumora corneana maligna
 - C. Fibromul este o tumora corneana benigna
 - D. Sarcoamele apar ca niste formatiuni carnoase bogat vascularizate
 - E. Epitelioamele sunt tumori corneene benigne

31. Rolul vitrosului este:

- 31 ABC
- A. Amortizeaza socurile si miscarile oculare
 - B. Functie reglatorie asupra presiunii intraoculare
 - C. Este un mediu transparent cu indice de refractie 1,336, cu rol optic
 - D. Impiedica formarea neovaselor intraretiniene
 - E. Prin opacifiere ofera protectie retineana impotriva razelor uv

32 ABE

32. urmatoarele afirmatii sunt corecte:

- A. Hemoragia vitreana poate evolua catre resorbtie spontana sau organizarea ei
- B. Hemoragiile vitreene propriu-zise pot fi localizate in canalul Cloquet
- C. Hemoragiile secundare pot fi localizate in canalul Cloquet
- D. Tratamentul hemoragiilor vitreene este strict medicamentos
- E. Hemoragiile vitreene se insotesc de scaderea acuitatii vizuale

33. Traumatismele corneei sunt reprezentate de:

- 33 CDE
- A. Keratoconus
 - B. Keratoconjunctivita
 - C. Eroziunea corneana
 - D. Plaga corneana
 - E. Corp strain cornean

34. dintre afectiunile oculare cataractogene mai frecvent intalnite amintim:

- 34 BCD
- A. Hipermetropia
 - B. Miopa forte
 - C. Uveitele
 - D. Sindromul de pseudoexfoliere capsulara
 - E. Conjunctivita alergica

35. Unghiul camerular:

35 ABC

- A. La nivelul său se face filtrarea umorii apoase.
B. Este implicat în patologia glaucomului.
C. Este spațiul situat la periferia camerei anterioare a globului ocular.
D. Se poate examina la lumina zilei.
E. Este alcătuit din următoarele structuri: maculă, fovee, foveolă.

36 Cristalinul:

ABCD

- A. Este o structură avasculară.
B. Este învelit de capsula cristalinului.
C. Are formă biconvexă.
D. Grosimea sa poate crește semnificativ în cursul procesului de acomodare.
E. Are formă biconcavă.

37 Există trei mecanisme fizice implicate în secreția și formarea umorului apos:

37 ABCE

- A. secreția activă de la nivelul epitelului cu celule clare
B. secreția activă ce se realizează prin consum energetic controlat de o baterie enzimatică
C. ultrafiltrarea ce implică diferența de presiune hidrostatică dintre lumenul capilar și PIO
D. difuzia pasivă simplă ce implică consum energetic controlat de o baterie enzimatică
E. difuzia pasivă simplă ce implică diferența de concentrație a ionilor

38 Neuroretinitele:

38 ACE

- A. caracterizate prin edemul discului optic și exudate maculare
B. caracterizate prin edemul discului optic și exudate peripapilare
C. exudatele dure se prezintă frecvent într-o formă de stea
D. tratamentul cu metilprednisolon intravenos poate agrava funcția vizuală
E. în majoritatea cazurilor, sunt idiopatice

39. Este fals despre dacrioadenita acută:

39 DE

- A. Diagnostic diferențial: abces palpebral, tumora de glanda lacrimală, celulită orbitară
B. Tratament: antibiotice și antiinflamatoare nesteroidiene, antitermice
C. Etiologie: endogenă (mai frecvent)
D. Etiologie: exogenă (mai frecvent)
E. Etiologie : endogena (mai rar)

40. Sclerita:

40 ABD

- A. sclerita reprezintă un proces inflamator profund, mai sever, asociat frecvent cu o boală de țesut conjunctiv cum ar fi poliartrita reumatoidă, lupusul eritematos
B. evoluția scleritei este lentă și îndelungată
C. evoluția scleritei este rapidă
D. semne și simptome: dureri oculare mari, cefalee, fotofobie, lăcrimare, simptome ce se accentuează la mișcările ochiului sau la presiune
E. o picătură de adrenalină va face să dispară congestia conjunctivală ce însoțește flictena, pe când congestia sclerală persistă sau se reduce parțial.

41 Tumorile conjunctivale sunt :

41 BCDE

- A. Melanomul malign coroidian
- B. Carcinomul conjunctival în situ
- C. Angiosarcomul Kaposi al conjunctivei
- D. Dermoidul
- E. Lipodermoidul

42. Care sunt muschii extraoculari care au ca si actiune adductia glubului ocular ?

42 ACE

- A.muschiul drept intern
- B.muschiul drept extern
- C. muschiul drept inferior
- D.muschiul oblic superior
- E.muschiul drept superior

43. Nervul III (oculomotor) asigura inervatia urmatorilor muschi extraoculari:

43 ACD

- A.muschiul drept intern
- B.muschiul drept extern
- C. muschiul drept inferior
- D.muschiul drept superior
- E.muschiul oblic superior

44. Care afirmatii sunt adevarate despre emfizemul palpebral ?

44 ACD

- A.aerul patrunde inaintea septului orbital
- B. aerul patrunde in spatele septului orbital
- C.realizeaza aspect patognomonic de crepitatie gazoasa
- D. apare de regula post – traumatic
- E. globul este exoftalm , imobil

45 Contuziile oculare pot produce la nivelul cristalinului :

45 ABC

- A. luxatie cristaliniana
- B.subluxatie cristaliniana
- C. opacifieri la nivelul cristalinului
- D.edem papilar
- E.atrofie optica

46 Diagnosticul diferential al exoftalmiei se face cu :

46 BCDE

- A. ochiul hipermetopic mare
- B.ochiul miopic mare
- C. keratocon
- D.keratoglob
- E.stafilom scleral

47 In cazul unei plagi profunde la nivel palpebral tratamentul este reprezentat de

47 BCD

- A. Tratament strict medical
- B. Tratament chirurgical
- C. Administrare de antibiotice
- D. Efectuare ATPA

E. Efectuarea ATPA nu este necesara

48. Hematocorneea

48 ABCD

- A. Reprezinta o impregnatie hematica a corneei
- B. Poate fi cauza unui traumatism contuziv ocular
- C. Prezinta un aspect brun-roscat al corneei
- D. Se poate complica cu glaucom secundar
- E. Este caracterizata de o hemoragie masiva localizata in corpul vitros

49. Dupa natura lor, leziunile traumatice ale organului visual pot fi

49 BCD

- A. Iritatii conjunctivale
- B. Contuzii
- C. Plagi taiate sau intepate cu sau fara retinere de corp strain
- D. Arsuri chimice sau fizice
- E. Eroziuni

50. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate

50 ABC

- A. In cazul unei plagi oculare penetrante tratamentul chirurgical trebuie instituit cat mai devreme
- B. Plagile intepate se inchid spontan
- C. Se practica repositionarea irisului prolabat in cazul in care nu au trecut mai mult de 2 h de la accident
- D. In cazul unei plagi oculare penetrante tratamentul chirurgical poate fi temporizat fara riscuri
- E. Se practica repositionarea irisului prolabat in cazul in care nu au trecut mai mult de 12 h de la accident